BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHOA NHI

Bản cập nhật từ file DOC, trình thẩm định ngày 14/10/2026. Gồm 19 mục kỹ thuật/hướng dẫn thiết bị; chưa ban hành.

Biên soạn: …… Thẩm định Nhi/Dược/KSNK/Thiết bị: …… Phê duyệt: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……

Phạm vi và căn cứ

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 dùng cho đề cương; thuốc và thao tác phải theo hướng dẫn chuyên môn, IFU thiết bị và phạm vi được phép. Giữ nội dung phù hợp nguồn năm 2025, bổ sung điều kiện an toàn theo tuổi/cân nặng. Bộ trước và bộ này có phần trùng nhưng khác phạm vi; không coi 19 mục tương đương toàn bộ bộ Nhi trước.

Chưa có model/IFU và phác đồ đầy đủ của bệnh viện. Các khoảng cách đèn, cường độ, thông số CPAP/ly tâm/bơm và liều phải được xác nhận trước triển khai. Không dùng ảnh hoặc nút bấm của hệ Benveniste/một máy để vận hành model khác. Các bảng kiểm nguồn năm 2007 có thông số cũ được thay bằng bảng kiểm chung và xác nhận cụ thể ở cuối bộ; không tiếp tục dùng bảng cũ cùng bản này.

Tài liệu này không thay quy trình truyền máu, hồi sức sơ sinh, chống độc hoặc vận hành phòng xét nghiệm được bệnh viện phê duyệt. N-2025-01 đến N-2025-19 là mã đề xuất.

Danh mục

01. BƠM DIAZEPAM QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN
02. CHIẾU ĐÈN VÀNG DA
03. PHUN KHÍ DUNG VỚI JET NEBULIZER
04. TRUYỀN HỒNG CẦU LẮNG VÀ MÁU TOÀN PHẦN
05. LẤY MÁU MAO MẠCH
06. NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY Ở TRẺ SƠ SINH
07. RỬA DẠ DÀY TRONG NGỘ ĐỘC CẤP
08. THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI (NCPAP)
09. HỆ THỐNG THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI (NCPAP)
10. 10. MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN
11. MÁY ĐO VI DUNG TÍCH HỒNG CẦU
12. MÁY THỬ ĐƯỜNG HUYẾT BẰNG QUE
13. MÁY TRUYỀN DỊCH
14. DINH DƯỠNG QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY
15. BƠM THUỐC TĨNH MẠCH QUA KHÓA LƯU KIM
16. HÚT ĐÀM MŨI MIỆNG
17. THIẾT LẬP ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN
18. THỞ OXY QUA CANNULA 2 MŨI
19. TRUYỀN DỊCH

N-2025-01. BƠM DIAZEPAM QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN

1. ĐẠI CƯƠNG

Cắt cơn co giật

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh co giật.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tiêu chảy

Tổn thương niêm mạc hậu môn.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

Chống co giật theo phác đồ Nhi; tính liều trước viện và tổng benzodiazepine, theo dõi hô hấp và chuẩn bị bóp bóng; không dùng ống tiêm sâu cố định theo tuổi lớn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Thuốc Diazepam (1 ống 10mg/2ml)

Ống tiêm 1ml (2 ống tiêm nếu liều thuốc >1ml)

Mâm sạch

Găng tay sạch

Xe tiêm thuốc: hộp chống sốc, hộp đựng sắc nhọn, thùng phân loại rác thải

Dung dịch sát trùng tay nhanh

Cồn 70 độ C

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Kiểm tra y lệnh hồ sơ: thuốc, liều thuốc.

Mang khẩu trang, rửa tay.

Chuẩn bị dụng cụ, mang đến giường người bệnh.

Thực hiện rút thuốc đúng quy trình, đúng y lệnh của bác sĩ.

Cởi bỏ quần hoặc tã của trẻ.

Đặt trẻ nằm nghiêng một bên với hai gối gập vào bụng.

Sát trùng tay nhanh, mang găng.

Dùng dụng cụ đưa thuốc trực tràng đúng chế phẩm/IFU và tuổi; không đưa thân bơm tiêm sâu 4–5 cm cho mọi trẻ. Không có kim trên dụng cụ. Liều theo mg/kg, trần mg và ml đã xác nhận; xem liều chống co giật đã dùng trước viện.

Bơm thuốc chậm và quan sát người bệnh.

Rút ống tiêm ra, khép mông trẻ và giữ trong vài phút.

Tháo bỏ găng, rửa tay, ghi hồ sơ

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-02. CHIẾU ĐÈN VÀNG DA

1. ĐẠI CƯƠNG

Giảm billirubin gián tiếp trong máu ở trẻ sơ sinh phòng ngừa vàng da nhân

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định dựa bilirubin, tuổi sau sinh tính giờ, tuổi thai và nguy cơ thần kinh theo biểu đồ/phác đồ bác sĩ lựa chọn.

Không quyết định chiếu đèn chỉ từ vùng vàng da quan sát; vàng da sớm cần đánh giá khẩn và xét nghiệm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Vàng da tăng billirunbin trực tiếp.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

+ Một số chăm sóc đặc biệt như: trẻ phải được bộc lộ toàn thân, chỉ còn mặc tã, hai mắt trẻ được che chở bằng băng che mắt cản quang.

Băng che mắt cảng quang

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

+ Các xét nghiệm cần thực hiện trong thời gian chiếu đèn

+ Chế độ dinh dưỡng, vệ sinh trong thời gian chiếu đèn.

Ghi phiếu theo dõi thời gian sử dụng đèn

Đèn đúng model, phổ/cường độ chiếu được kiểm tra; thay/bảo trì theo IFU, không dùng 6–8 bóng hoặc 2.000 giờ chung cho mọi đèn.

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Kiểm tra y lệnh hồ sơ

Mang khẩu trang, rửa tay.

Chuẩn bị dụng cụ, mang đến giường người bệnh.

Bộc lộ da người bệnh đến mức tối đa

Đặt trẻ nằm ở vùng trung tâm của ánh sáng đèn

Băng che mắt cho người bệnh

Đặt khoảng cách và cường độ theo IFU/y lệnh; không mặc định 30–40 cm cho đèn LED và mọi thiết bị.

Bật công tắc đèn chiếu vàng da

Rửa tay, ghi hồ sơ

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Theo dõi nhiệt, mất nước, bú, da, mắt và bilirubin theo kế hoạch. Nhiệt tăng cần đánh giá môi trường, cường độ, mất nước/nhiễm trùng; không tự cho thuốc hạ sốt sơ sinh hoặc ngừng ½–1 giờ rồi tiếp tục khi chưa đánh giá. Bú kém, li bì, co gồng cần bác sĩ đánh giá khẩn.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo:
https://www.nice.org.uk/guidance/CG98/chapter/recommendations

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-03. PHUN KHÍ DUNG VỚI JET NEBULIZER

1. ĐẠI CƯƠNG

Đưa thuốc trực tiếp đến phế quản và phế nang thuốc sẽ có tác dụng nhanh và phù hợp khi dùng để cấp cứu

Hạn chế những tác dụng phụ toàn thân của thuốc

Thay thế MDI nếu người bệnh không dùng được MDI.

2. CHỈ ĐỊNH

Suyễn:

+ Cắt cơn suyễn

+ Phòng ngừa suyễn

Viêm thanh khí phế quản cấp, viêm tiểu phế quản

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Hướng dẫn gia đình người bệnh giữ trẻ đúng tư thế trong khi phun khí dung.

Kiểm tra phiếu thực hiện – công khai thuốc với y lệnh thuốc trong hồ sơ bệnh án khi thực hiện thuốc.

Bộ phun khí dung

+ Bình đựng thuốc

+ Mặt nạ phù hợp lứa tuổi (cỡ nhỏ, trung, lớn)

+ Dây nối

Hai ống tiêm 3ml (1 ống rút thuốc, 1 ống rút nước muối sinh lý Nacl 0.9%)

Chén chung, gòn khô

Băng keo cá nhân

Mâm

Nguồn khí: khí nén, nguồn khí trung tâm

Thuốc, dung dịch sát trùng, chế phẩm máu

Thuốc theo y lệnh:

+ Salbutamol

+ Adrenalin

Dung dịch nước muối sinh lý Nacl 0.9% để pha thuốc nếu thể tích thuốc <2.5ml

Cồn 70 độ

Dung dịch sát trùng tay nhanh

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

Máy nén khí hoặc nguồn oxy trung tâm.

Máy đo độ bão hòa oxy

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Lấy dấu hiệu sinh tồn, mắc máy đo độ bão hòa oxy nếu có chỉ định

Mang khẩu trang, rửa tay

Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ và phù hợp

Chuẩn bị thuốc theo y lệnh:

+ Thực hiện kiểm tra nhãn thuốc 3 lần: khi lấy thuốc, trước khi bẻ ống thuốc và sau khi rút thuốc.

+ Sát trùng ống thuốc và chai nước muối sinh lý Nacl 0.9%

+ Dùng 2 ống tiêm 3ml rút thuốc và rút nước muối sinh lý Nacl 0.9% cho vào mỗi ống tiêm riêng biệt, rút đủ liều theo y lệnh.

+ Bảo quản thuốc thừa và chai nước muối sinh lý Nacl 0.9% đúng theo quy định.

Sát trùng tay nhanh

Xác định đúng người bệnh

Tư thế thích hợp:

+ Trẻ lớn: ngồi

+ Trẻ nhỏ: mẹ bế ở tư thế ngồi hoặc nằm đầu cao

Kỹ thuật:

+ Bơm thuốc, nước muối sinh lý Nacl 0.9% vào bình đựng thuốc, gắn mặt nạ phù hợp

+ Nối bộ phun khí dung vào nguồn khí

+ Điều chỉnh lưu lượng khí sao cho hạt khí dung dạng sương mù (thường 6-8 lít/ phút)

+ Áp mặt nạ vào mũi miệng người bệnh, hướng dẫn trẻ hít thở bằng miệng

+ Phun cho đến khi hết thuốc, thời gian phun trung bình 10 phút

Quan sát tình trạng người bệnh trước, trong và sau khi phun thuốc: nhịp thở, kiểu thở, tím tái, SPO2

Dặn dò người bệnh/ người chăm sóc: những dấu hiệu diễn tiến nặng cần thông báo, giờ phun thuốc cử kế tiếp.

Dọn dẹp và xử lý dụng cụ

Rửa tay- ghi hồ sơ- phiếu công khai thuốc.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-04. TRUYỀN HỒNG CẦU LẮNG VÀ MÁU TOÀN PHẦN

1. ĐẠI CƯƠNG

Bồi hoàn lượng máu mất hoặc thiếu máu

2. CHỈ ĐỊNH

Khối hồng cầu đậm đặc (hồng cầu lắng)

Thay thế hồng cầu ở người bệnh thiếu máu

Máu toàn phần

Máu toàn phần chỉ khi bác sĩ/ngân hàng máu xác nhận phù hợp tình trạng mất máu và chiến lược truyền; không tự thay khối hồng cầu.

Truyền thay máu là kỹ thuật riêng, không thực hiện theo quy trình truyền thường quy này.

Không tự dùng máu toàn phần khi hết khối hồng cầu; liên hệ bác sĩ và ngân hàng máu.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Rút máu- đăng ký máu:

Lấy đúng loại ống/chất chống đông và thể tích theo xét nghiệm, tuổi và hướng dẫn ngân hàng máu; EDTA là chất chống đông, không chọn chỉ theo màu nắp. Ghi nhãn ngay tại giường với hai định danh, người lấy và thời gian.

Lãnh máu từ khoa xét nghiệm:

+ Điều dưỡng đối chiếu nhóm máu, số hiệu túi máu phù hợp với phiếu lãnh máu, kiểm tra máu và rò rỉ túi máu trước khi nhận.

+ Túi máu được đặt vào thùng khi vận chuyển từ khoa xét nghiệm về khoa.

Dây truyền máu có bầu lọc

Ống tiêm 5ml chứa Natri Chlorua 0.9%

Gòn viên

Chén chung

Găng tay sạch

Thùng đựng máu

Ống xét nghiệm/chất chống đông theo ngân hàng máu, không mặc định màu xanh dương.

Đồng hồ có kim giây để đếm giọt

Xe tiêm: hộp chống sốc, hộng đựng sắc nhọn, thùng phân loại rác thải,…

Phiếu lĩnh máu

Dụng cụ định nhóm máu ABO tại giường

Lam kính

Que tâm

Thuốc, dung dịch sát trùng, chế phẩm máu

Túi máu lãnh từ khoa xét nghiệm

Dụng cụ sát trùng: Alcol pass

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

+ Chỉ định trên máy: chỉ định máu, nhóm máu ABO, số lượng và thành phần máu, ngày giờ yêu cầu.

Trụ treo

Phiếu theo dõi truyền máu (trên máy)

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Kiểm tra, đối chiếu các thông tin:

Trên phiếu dự trù máu, nhãn túi máu, hồ sơ xét nghiệm định nhóm máu và phiếu truyền máu về:

Người bệnh nhận máu: họ tên, số hồ sơ, năm sinh, nhóm máu ABO, Rh(D), số giường bệnh, tên khoa phòng, chẩn đoán, chỉ định loại chế phẩm và thể tích truyền.

Đơn vị máu: mã số túi máu, nhóm máu ABO, Rh(D), tên loại chế phảm, thể tích, hạn sử dụng.

Kiểm tra túi máu trước khi truyền

Không sử dụng các đơn vị máu và chế phẩm máu, khi phát hiện thấy các dấu hiệu sau:

Thủng, hở, nứt, vỡ ở túi đựng, ống dây, vị trí cấm dây truyền.

Hiện tượng không phân lớp hoặc phân lớp bất thường giữa các thành phần máu khi đã để lắng hoặc li tâm.

Có máu sắc bất thường:

+ Màu hồng hoặc đỏ ở phần trên mặt phân cách huyết tương và hồng cầu hoặc toàn bộ huyết tương

+ Huyết tương có màu sắc bất thường

+ Phần hồng cầu đổi màu tím đỏ hoặc đen sẫm hoặc màu sắc bất thường khác.

Có cục máu đông.

Có nổi váng trên bề mặt.

Nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào tìm thấy trên túi máu thì không được truyền đơn vị máu đó và phải thông báo ngay cho khoa xét nghiệm.

Ngay trước khi bắt đầu truyền chế phẩm máu, điều dưỡng hoặc bác sĩ thực hiện việc kiểm tra lần cuối này ngay tại giường người bệnh:

Hai nhân viên theo quy định kiểm tra độc lập tại giường: hai định danh, vòng/hồ sơ, y lệnh, chế phẩm, ABO/RhD, tương hợp, mã túi, hạn dùng và thể tích. Không dùng số giường làm định danh.

Nếu người bệnh đang trong tình trạng hôn mê thì cần hỏi người nhà người bệnh hoặc vòng đeo tay để xác định chính xác người bệnh.

Kiểm tra chính xác người bệnh trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ bệnh án.

Truyền máu

Lấy dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

Mang khẩu trang, rửa tay

Sát trùng tay nhanh, mang găng tay sạch

Thử nhóm máu ABO của người bệnh và đơn vị máu trước truyền (thẻ định nhóm máu, lam kính)

Bác sĩ điều trị cần kiểm tra lại kết quả nhóm máu và quyết định việc thực hiện y lệnh truyền máu

Sát trùng và cấm dây truyền máu vào túi máu

Treo túi máu lên trụ treo và đuổi khí

Kiểm tra kim luồn nằm trong lòng mạch, bơm đuổi kim luồn bằng Natri Chlorua 0.9% và gắn dây truyền máu

Khởi đầu chậm theo y lệnh ml/giờ và cân nặng, theo dõi trực tiếp 15 phút đầu; không dùng 5–10 giọt/phút chung cho mọi dây/trẻ.

Điều chỉnh tốc độ cho đến mức theo y lệnh bác sĩ

Không được bổ sung chất gì (bao gồm các loại thuốc) vào túi máu, trừ trường hợp có chỉ định hòa loãng khối hồng cầu thì chỉ được sử dụng dung dịch muối đẳng trương (Nacl 0.9%) loại truyền tĩnh mạch theo y lệnh

Dọn dẹp dụng cụ, tháo găng, ghi hồ sơ.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Phản ứng truyền máu: ngừng, đánh giá ABCDE, gọi bác sĩ/ngân hàng máu; giữ túi/dây, kiểm tra định danh và xử lý mẫu theo quy trình. Không truyền lại hoặc đẩy máu trong dây vào trẻ. Thể tích/tốc độ theo cân nặng và tình trạng, theo dõi quá tải.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo:
https://www.rch.org.au/bloodtrans/blood_administration/Blood_administration/

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-05. LẤY MÁU MAO MẠCH

1. ĐẠI CƯƠNG

Lấy một lượng máu nhỏ ở chi để xét nghiệm dung tích hồng cầu, đường huyết, khí máu.

2. CHỈ ĐỊNH

Dung tích hồng cầu (DTHC)

Đường huyết bằng que (Dextrotix)

Khí máu mao mạch khi không lấy được máu động mạch

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Lancet vô khuẩn dùng một lần, độ sâu phù hợp tuổi/cân nặng và vị trí; không mặc định 2,4 mm cho gót sơ sinh.

Alcool pass

Gòn khô

Mâm sạch

Dung dịch sát trùng tay nhanh

Dụng cụ chưa máu:

+ Xét nghiệm dung tích hồng cầu: ống mao dẫn, đất sét

Găng tay sạch

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

+ Xét nghiệm Dextrotix: que thử, máy đo

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. Kiểm tra y lệnh hồ sơ

2. Mang khẩu trang, rửa tay.

3. Báo và giải thích cho thân nhân bệnh nhân

4. Chuẩn bị dụng cụ, mang đến giường người bệnh.

5. Chọn vị trí đâm lancet:

+ Sơ dinh, trẻ nhỏ: đâm ở vùng rìa hai bên gót chân

+ Trẻ lớn: đâm ở mặt bên của đầu ngón tay

+ Không chọn vị trí đã đâm lancet trước đó, hoặc vùng da bị tổn thương

6. Thực hiện:

+ Sát trùng tay nhanh

+ Mang găng tay sạch

+ Sát trùng vị trí lấy máu, sau đó để khô

Làm ấm chỉ theo xét nghiệm và phương tiện an toàn, kiểm soát nhiệt/da; không xoa/nặn mạnh, không làm nóng kéo dài tùy ý.

+ Đâm lancet, để máu tự chảy, không nặn

Xử lý giọt đầu theo loại xét nghiệm/IFU máy, không áp cùng quy tắc cho mọi thiết bị.

+ Sau khi có đầy giọt máu, đặt ống mao quản (DTHC, khí máu) hoặc que thử (Dextrotix) vào để lấy máu.

+ Dùng gòn khô ấn vào nơi lấy máu đến khi máu ngưng chảy

+ Ghi nhãn mẫu máu và gửi ngay đến phòng xét nghiệm

7. Dọn dẹp dụng cụ

8. Rửa tay, ghi hồ sơ

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo:
https://www.who.int/publications/i/item/9789241599221

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-06. NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY Ở TRẺ SƠ SINH

1. ĐẠI CƯƠNG

Đưa thức ăn qua ống thông vào dạ dày để nuôi dưỡng bệnh nhân

2. CHỈ ĐỊNH

- Bú không đủ nhu cầu
- Trẻ sanh non < 32 tuần
- Phản xạ bú nuốt yếu do bệnh nặng sanh ngạt
- Suy hô hấp: nhịp thở> 75 lần/ phút, rút lõm ngực nặng, thở NCPAP, giúp thở
- Bất thường vùng hầu họng: sứt môi, chẻ vòm hầu, tịt mũi sau, lưỡi to

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Suy hô hấp nặng chưa được hỗ trợ hô hấp

Đang sốc, co giật

Xuất huyết tiêu hóa

Nghi ngờ bệnh lý ngoại khoa cần can thiệp

Giai đoạn đầu hậu phẫu đường tiêu hóa

Trong 6 giờ đầu sau thay máu

Viêm ruột hoại tử sơ sinh trong giai đoạn đầu

Dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

Không cho ăn/thuốc trước xác nhận vị trí ống; không dùng nghe bơm khí hay thử nhúng nước. RCH dùng pH dịch hút ≤5; ngưỡng/phương pháp phải được bệnh viện xác nhận. Không đủ bằng chứng thì dừng, báo bác sĩ và xác nhận hình ảnh khi cần.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Tư thế theo kế hoạch sơ sinh và điều kiện giám sát; không dùng tư thế đầu cao 30° cho mọi sơ sinh. Hướng dẫn nằm ngủ an toàn khi về nhà khác với tư thế được chỉ định khi chăm sóc có giám sát.

Ống tiêm 5ml

Ly nước chín

Chai cho ăn và dây nhỏ giọt

Sữa ấm: sữa mẹ hay sữa công thức phù hợp tuổi thai và cân nặng nếu không có sữa mẹ

Ống tiêm 20ml, dây nối bơm tiêm (nếu cần)

Dụng cụ treo chai sữa

Bồn hạt đậu

Ống nghe

Dung dịch sát trùng tay nhanh

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

Máy bơm sữa

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Mang khẩu trang, rửa tay

Chuẩn bị dụng cụ mang đến giường bệnh nhân

Gắn lồng treo vào chai thức ăn

Cắm dây nhỏ giọt vào chai sữa, khóa van dây nhỏ giọt, treo chai sữa lên trụ treo rồi đuổi khí. Khóa van dây sau khi đuổi khí.

Xác nhận vị trí ống trước dùng bằng dấu chiều dài và dịch hút/pH theo quy trình; không nghe bơm khí. Khi không đủ bằng chứng, không cho ăn, báo bác sĩ xác nhận X-quang khi cần.

Chỉ sử dụng sau xác nhận đúng; nghi di lệch phải dừng và báo nhân viên có năng lực, không cho ăn thử để kiểm tra.

Lượng và tốc độ theo cân nặng/tuổi thai, chế độ bolus/liên tục và dung nạp; không dùng 30–60 phút chung cho mọi cữ.

Theo dõi sát 15 phút đầu, dặn dò gia đình quan sát và báo ngay khi thấy trẻ tím tái hoặc nôn ói.

Kết thúc cho ăn: gỡ bỏ dây chai cho ăn. Lưu ý khóa van dây nhỏ giọt trước khi tháo bỏ để tránh sữa chảy ra ngoài

Nước/thể tích tráng ống theo kế hoạch sơ sinh, tính vào tổng dịch; không mặc định 5 ml.

Theo dõi hô hấp/dung nạp sau ăn và tư thế được chỉ định, không dùng một góc/thời gian cho mọi trẻ.

Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ

Xử trí dịch dư

Dịch mật/máu, bụng chướng hoặc dấu không dung nạp: ngừng ăn và báo bác sĩ đánh giá khẩn, không tự xử trí chỉ bằng dẫn lưu.

Đánh giá dung nạp theo kế hoạch; không tự hút tồn dư thường quy hoặc đổi chế độ chỉ dựa mốc 75 ml/kg/ngày.

Lượng/màu dịch, triệu chứng, bụng và toàn trạng cùng được bác sĩ đánh giá; không dùng >50% làm tiêu chí dẫn lưu tự động.

Không tự bơm trả/bỏ dịch hoặc giảm lượng ăn theo công thức 30–50%; xử trí theo kế hoạch cá thể.

Không dùng <30% để tự điều chỉnh cữ; ghi nhận và thực hiện chỉ định phù hợp dung nạp.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo

động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Nôn, mật/máu, bụng chướng, tím/ngừng thở: ngừng ăn, đánh giá và báo bác sĩ. Xử trí tồn dư theo toàn trạng/phác đồ, không tự bơm trả/bỏ hoặc giảm cữ chỉ từ tỷ lệ phần trăm.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Nasogastric_and_Orogastric_Tube_Insertion_and_Management/

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-07. RỬA DẠ DÀY TRONG NGỘ ĐỘC CẤP

1. ĐẠI CƯƠNG

Loại bỏ độc chất còn nằm trong dịch dạ dày trong trường hợp người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

2. CHỈ ĐỊNH

Rửa dạ dày không thực hiện thường quy trong ngộ độc. Chuyên khoa lựa chọn hiếm trường hợp lợi ích vượt nguy cơ, xét độc chất, lượng, thời điểm và đường thở; không coi trong 6 giờ là bảo đảm hiệu quả.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Ngộ độc chất ăn mòn: acid, kềm

Ngộ độc chất bay hơi: xăng, dầu hôi

Đang co giật

Hôn mê chưa đặt nội khí quản có bóng chèn

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

Chỉ thực hiện khi chuyên khoa chống độc/bác sĩ xác nhận lợi ích vượt nguy cơ và đủ bảo vệ đường thở; không rửa thường quy. Không dùng tổng lượng lít cố định hay cố rửa đến trong cho mọi trẻ.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Đánh giá tình trạng người bệnh: tri giác, dấu hiệu sinh tồn, SPO2

Ống rửa dạ dày (Faucher) cỡ trẻ em, trẻ lớn

Dùng ống thông dạ dày có kích thước lớn: người bệnh hôn mê, trường hợp không có ống Faucher

Ống tiêm 50 ml (rút dịch dạ dày để kiểm tra vị trí ống thông)

Gạc

Cây đè lưỡi

Que gòn (đặt qua dường mũi)

Ly nước chín

Găng sạch

Mâm sạch

Ống nghe

Băng keo

Lọ bệnh phẩm xét nghiệm độc chất trong dịch dạ dày

Xô đựng nước: 02 (1 chứa dung dịch rửa, 1 chứa nước chảy ra)

Dụng cụ đong nước(có chia thể tích)

Khăn lau, tạp dề

Dây cố định người bệnh

Dung dịch, nhiệt độ, ml mỗi chu kỳ và tổng lượng do bác sĩ xác nhận theo cân nặng; không chuẩn bị y lệnh 10–20 lít cho mọi trẻ.

Than hoạt chỉ khi có chỉ định và phù hợp độc chất/đường thở, không mặc định sau mọi rửa dạ dày.

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Mang tạp dề

Mang khẩu trang, rửa tay, mang găng sạch

Chuẩn bị lượng/dịch đúng y lệnh cá thể, kiểm tra cân nặng và phương tiện thu đo vào-ra; không lấy 10–20 lít làm mục tiêu.

Đặt xô chứa dịch dạ dày chảy ra thấp hơn người bệnh

Tư thế và bảo vệ đường thở theo bác sĩ, hỗ trợ trẻ an toàn; không trói/cố định trẻ để cố làm khi không đủ điều kiện.

Đo ước lượng chiều dài ống thông cần đặt và đánh dấu bằng viết lông kim

Đặt ống rửa dạ dày qua đường miệng

Xác nhận vị trí bằng phương pháp được phê duyệt; dịch hút đơn thuần không đủ khi nghi sai đường, không nghe khí hoặc nhúng đầu ống vào nước.

Lấy dịch dạ dày cho vào lọ xét nghiệm gửi phân tích độc chất hoặc vi sinh nếu có chỉ định

Rút bỏ tối đa dịch dạ dày có chứa độc chất trước khi rửa giúp cho việc loại bỏ độc chất được tốt hơn và hạn chế độc chất xuống ruột khi rửa dạ dày

Rửa dạ dày: dung dịch rửa theo y lệnh

Đưa dịch theo kỹ thuật/y lệnh đã xác nhận và theo dõi, không áp độ cao phễu chung cho mọi trường hợp.

Thể tích/chu kỳ, giới hạn và tiêu chí dừng theo phác đồ cá thể; ghi cân nặng và kiểm tra độc lập trước thực hiện.

+ Khi còn 1 ít nước trong phễu, hạ phễu nhanh xuống cho dịch chảy ra trong xô chứa

Dừng theo tiêu chí chuyên khoa và tình trạng; ghi cân bằng vào-ra, không rửa đến “trong/không mùi” bằng 5–20 lít cố định.

+ Luôn quan sát sắc mặt người bệnh trong khi rửa

Than hoạt nếu được chỉ định: đúng liều/nồng độ/đường và trần theo phác đồ Nhi, không tự bơm theo công thức chung; đánh giá bảo vệ đường thở.

Rút ống thông rửa dạ dày bằng cách gập ống thông và từ từ rút ra

Vệ sinh, chuyển người bệnh về giường, cho nằm lại tiện nghi

Đánh giá tình trạng người bệnh ngay sau khi rửa dạ dày: tri giác, dấu hiệu sinh tồn, SPO2

Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ

Cách đo chiều dài và thử ống thông

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.jem-journal.com/article/S0736-4679%2813%2900716-6/fulltext

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-08. THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI (NCPAP)

1. ĐẠI CƯƠNG

Cung cấp luồn khí tạo áp lực dương liên tục trên đường thở người bệnh trong suốt chu kỳ thở với van Benveniste

Tác dụng tránh xẹp phế nang cuối thì thở ra, giảm công thở, tăng trao đổi oxy ở người bệnh có bệnh lý tổn thương phổi. Hỗ trợ cho người bệnh suy hô hấp còn tự thở

2. CHỈ ĐỊNH

- Cơn ngưng thở ở trẻ sơ sinh sinh non
- Hội chứng suy hô hấp sơ sinh (bệnh màng trong)
- Viêm phổi hít
- Viêm phổi thất bại với oxy
- Phù phổi cấp do tim
- Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS)
- Ngạt nước
- Xẹp phổi do tắc đàm
- Viêm tiểu phế quản
- Hậu phẫu lồng ngực/ chấn thương ngực
- Cai máy

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tràn khí màng phổi chưa dẫn lưu

Tăng áp lực nội sọ: xuất huyết não, viêm não màng não

Bệnh lý phổi tắc nghẽn có tăng thể tích khí cặn chức năng (FRC) như suyễn, khí phế thũng

Sốc giảm thể tích chưa bù dịch

Thoát vị hoành

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Đo SPO2, đếm mạch, nhịp thở, quan sát kiểu thở, tình trạng tím tái

Cho người bệnh nằm đầu cao giúp bớt khó thở và tránh nôn ói hít sặc

Vệ sinh mũi hoặc hút đàm nhớt (nếu cần)

Hệ thống dẫn khí: dây nối bộ trộn khí với bình làm ẩm, ống xoắn và dây nối giữa nhiệt kế với van Benveniste, bẫy nước.

Nhiệt kế rượu và ba chia gắn nhiệt kế

Van Benveniste

Cannula cỡ thích hợp (S: sơ sinh, M: trẻ nhỏ, L: trẻ lớn)

Dụng cụ cố định:

+ Sơ sinh: cố định qua nón

+ Trẻ lớn: băng keo

Dụng cụ khác:

+ Dụng cụ vệ sinh mũi: que gòn

+ Bồn hạt đậu

+ Chai sát trùng tay nhanh

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

Bộ trộn khí (lưu lượng kế oxy và lưu lượng kế khí nén)

Dụng cụ làm ấm, ẩm: nồi làm ấm, buồng làm ẩm và giấy thấm, nước cất

Áp kế cột nước để đo áp lực CPAP

Bảng mối liên hệ giữa lưu lượng với áp lực và FiO2

Máy đo độ bão hòa oxy

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Mang khẩu trang, rửa tay

Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, mang đến giường bệnh

Sát trùng tay nhanh

Lắp hệ thống thở áp lực dương liên tục:

+ Gắn đầu cắm của lưu lượng kế vào các van của khí nén và oxy

+ Cố định nồi làm ấm lên giá đỡ

+ Sát trùng tay nhanh

+ Chuẩn bị bình làm ẩm: bình có giấy thấm hoặc không có giấy thấm

Đổ nước cất vô trùng vào bình làm ẩm đến mức tối đa (max)

Đặt bình làm ẩm vào nồi làm ẩm

+ Lắp hệ thống dây dẫn:

Nối dây từ bộ phận trộn khí đến bình làm ẩm

Gắn hệ thống dây xoắn từ bình làm ẩm đến bẫy nước và đến ba chia

Gắn nhiệt kế, mặt số nhiệt kế quay ra trước

Gắn dây nối từ nhiệt kế đến van benveniste

+ Điều chỉnh oxy và khí nén để đạt được FiO2 và áp lực theo y lệnh, kiểm tra áp lực bằng áp kế cột nước trước khi sử dụng cho người bệnh

Gắn cannula vào van Benveniste

Gắn cannula vào mũi người bệnh và cố định

Cài nguồn điện, nhiệt và làm ẩm theo model/IFU, kiểm tra trước nối trẻ; không áp 33±1°C cho mọi hệ.

Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ

Hình minh họa

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Theo dõi liên tục oxy hóa và tình trạng hô hấp khi cần; mục tiêu SpO_2 theo tuổi thai/bệnh, không áp một mục tiêu cho tất cả. Xấu đi, ngưng thở/nhịp chậm hoặc nghi tràn khí: hỗ trợ ngay, gọi bác sĩ; không trì hoãn nâng mức hỗ trợ bằng sửa máy kéo dài. Kiểm tra da mũi, áp lực, FiO_2, làm ẩm và rò hệ theo IFU.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/piper/neonatal-cpap-learning-package.pdf

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-09. HỆ THỐNG THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI (NCPAP)

1. ĐẠI CƯƠNG

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cơn ngưng thở ở trẻ sơ sinh sinh sinh non
- Hội chứng suy hô hấp sơ sinh (bệnh màng trong)
- Viêm phổi hít
- Viêm phổi thất bại với oxy
- Phù phổi cấp
- Hội chứng suy hô hấp cấp
- Ngạt nước
- Xẹp phổi do tắc đàm
- Viêm tiểu phế quản
- Hậu phẫu lồng ngực/ chấn thương ngực
- Cai máy thở

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

- Van Benveniste và cannula
- Bình làm ẩm và giấy thấm
- Hệ thống dây dẫn (dây nối bộ trộn khí với bình làm ẩm, ống xoắn và dây nối giữa nhiệt kế với van Benveniste)

- Nhiệt kế rượu và ba chia gắn nhiệt kế
- Bẫy nước
- Nước cất vô trùng

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

- Bộ trộn khí (lưu lượng kế oxy và lưu lượng kế khí nén)
- Nồi làm ấm
- Áp kế cột nước

Áp kế cột nước đo áp lực CPAP Nón cố định

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Rửa tay

Chuẩn bị dụng cụ, chọn cỡ cannula thích hợp, dụng cụ cố định cannula

Lắp hệ thống thở áp lực dương liên tục:

+ Gắn đầu cắm của lưu lượng kế vào các van của khí nén và oxy

+ Cố định nồi làm ấm lên giá đỡ

+ Sát trùng tay nhanh

+ Chuẩn bị bình làm ẩm: bình có giấy thấm hoặc không có giấy thấm

Đổ nước cất vô trùng vào bình làm ẩm đến mức tối đa (max)

Đặt bình làm ẩm vào nồi làm ẩm

+ Lắp hệ thống dây dẫn:

Nối dây từ bộ phận trộn khí đến bình làm ẩm

Gắn hệ thống dây xoắn từ bình làm ẩm đến bẫy nước và đến ba chia

Gắn nhiệt kế, mặt số nhiệt kế quay ra trước

Gắn dây nối từ nhiệt kế đến van benveniste

Gắn canunula vào van Benveniste

+ Gắn cannula vào mũi người bệnh và cố định

Cài nhiệt/làm ẩm và nguồn điện theo đúng thiết bị/IFU, kiểm tra trước nối trẻ; không đặt 33±1°C mặc định mọi hệ.

Cài lưu lượng, áp lực, FiO_2 theo y lệnh/IFU, kiểm tra áp lực/oxy và báo động trước nối trẻ; điều dưỡng không tự chỉnh ngoài kế hoạch.

Hình minh họa

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Theo dõi liên tục oxy hóa và tình trạng hô hấp khi cần; mục tiêu SpO_2 theo tuổi thai/bệnh, không áp một mục tiêu cho tất cả. Xấu đi, ngưng thở/nhịp chậm hoặc nghi tràn khí: hỗ trợ ngay, gọi bác sĩ; không trì hoãn nâng mức hỗ trợ bằng sửa máy kéo dài. Kiểm tra da mũi, áp lực, FiO_2, làm ẩm và rò hệ theo IFU.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/piper/neonatal-cpap-learning-package.pdf

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-10. 10. MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN

1. ĐẠI CƯƠNG

Bơm thuốc và các loại dịch, chế phẩm máu vào cơ thể người bệnh đúng tốc độ.

Dùng điện tạo lực đẩy pít tông của ống tiêm theo tốc độ bơm được cài đặt đều và chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Các thuốc cần tốc độ truyền chính xác:

+ Thuốc vận mạch: dopamine, dobutamine, eniphrine,…

+ Thuốc khác: insulin

- Các thuốc cần tiêm tĩnh mạch chậm: diaphilline, furosemide, vanconmycin, …
- Các loại dịch và chế phẩm máu có thể tích cần truyền nhỏ
- Giữ thông các đường truyền động mạch và tĩnh mạch trung tâm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

+ Những lưu ý đặc biệt: dùng thuốc trước ăn hay sau ăn, giờ chính xác, theo dõi sau dùng thuốc.

Thuốc/dung môi/nồng độ theo nhãn và y lệnh, không mặc định dextrose 5% hoặc NaCl cho mọi thuốc.

Ống tiêm đúng cỡ/hãng tương thích IFU, không mặc định 20 hoặc 50 ml.

- Ống tiêm 3ml hoặc 5ml để rút thuốc
- Dây nối bơm tiêm

Dung dịch bơm rửa với thể tích cá thể theo đường truyền, tính vào tổng dịch.

- Gòn, dung dịch cồn 70 độ
- Dung dịch sát trùng tay nhanh
- Mâm

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

- Máy bơm tiêm điện
- Bồn hạt, trụ treo

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Rửa tay

Chuẩn bị dụng cụ

Pha thuốc theo y lệnh, nối vào dây nối bơm tiêm và đuổi khí

Kiểm tra kim nằm trong lòng mạch

+ Cố định máy lên trụ treo và cấm điện 220V

+ Sát khuẩn tay nhanh

Lắp ống/dây theo IFU; chuẩn bị/đuổi khí trước nối trẻ, khóa đường theo hướng dẫn để tránh bolus hoặc chảy tự do.

Lắp và giữ ống theo đúng model, không áp thao tác cần giữ trái/phải của một máy cho mọi máy.

Kiểm tra nòng, pít tông và nhận diện ống đúng IFU.

Đặt ống đúng vị trí, xác nhận nhận diện của máy.

Khóa cơ cấu chống chảy tự do theo IFU trước nối trẻ.

+ Gắn dây nối bơm tiêm vào bệnh nhân

Khởi động và kiểm tra tự kiểm tra/báo động theo model.

Hai nhân viên kiểm tra y lệnh, nồng độ, mg/kg, ml/giờ, giới hạn và tổng thể tích khi thuốc nguy cơ cao; cài đúng đơn vị.

Ấn nút " START" máy hoạt động

Thay tốc độ theo y lệnh, ghi thời điểm và kiểm tra lại, không tự chỉnh chỉ vì báo động.

PURGE/đuổi khí chỉ khi không nối trẻ và theo IFU; không dùng nút này để bolus thuốc cho trẻ. Bolus điều trị cần y lệnh/chế độ riêng.

Theo dõi hoạt động máy và quan sát đường truyền, nơi tiêm bệnh nhân

Dọn dẹp dụng cụ, ghi hồ sơ

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Nghi thoát mạch: ngừng truyền, không bơm rửa, giữ catheter ban đầu cho đánh giá/hút thuốc khi phù hợp; báo bác sĩ, ghi thuốc/vùng/thể tích và tưới máu. Tắc: không dùng PURGE hoặc tăng áp đẩy cục máu vào trẻ; khi tháo tắc phải tránh bolus sau giải phóng áp theo IFU. Nghi đứt catheter phải báo ngay, không chỉ đặt lại.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-11. MÁY ĐO VI DUNG TÍCH HỒNG CẦU

1. ĐẠI CƯƠNG

Với vận tốc xoay vòng của dĩa máy quay quanh trục cùng với thời gian qui định thì các thành phần của máu được tách ra làm hai phần hồng cầu và huyết tương. Dung tích hồng cầu được xác định bằng cách tính tỉ lệ % của thể tích hồng cầu(phần đỏ nằm phía dưới của ống mao quản) so với tổng thể tích.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thiếu máu
- Sốt xuất huyết
- Xuất huyết
- Đa hồng cầu

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

+ Những việc cần sự hỗ trợ của gia đình: giữ tư thế người bệnh trong lúc lấy máu, ấn chặt nơi tiêm sau khi lấy máu xong.

- Ống mao quản
- Đất sét
- Thước đo dung tích hồng cầu

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

- Máy quay dung tích hồng cầu

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Sau khi lấy mẫu máu vào ống mao quản ít nhất đạt được 75% chiều cao của ống và đã được bít một đầu ống bằng đất sét.

Chuẩn bị máy, cấm điện 220V

Các bước tiến hành

+ Ấn mở nắp ngoài

+ Kéo lên mở nắp trong

+ Để ống mao quản vào rãnh vòng xoay, phần đất sét quay ra ngoài, luôn đặt đối xứng để giữ thăng bằng khi máy quay

+ Kéo lên đóng nắp trong

+Ấn đóng nắp ngoài

Cài tốc độ/RCF và thời gian theo IFU và phương pháp xét nghiệm đã xác nhận; loại bỏ số 120.000 vòng/phút chưa được xác minh. Không tự thay bằng số phỏng đoán.

+ Ấn nút Star

Chờ máy dừng hoàn toàn theo IFU rồi mở nắp; ghi chương trình thực dùng.

Đọc kết quả:

+ Di chuyển thước đo xoay vòng sao cho điểm thấp nhất giữa hồng cầu và đất sét trùng với mức 0%, điểm cao nhất ở phần huyết tương sẽ trùng với mức 100%

+ Đọc kết quả dung tích hồng cầu % tại điểm cao nhất của hồng cầu.

Dọn dụng cụ và ghi hồ sơ, báo bác sĩ kết quả

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-12. MÁY THỬ ĐƯỜNG HUYẾT BẰNG QUE

1. ĐẠI CƯƠNG

Định lượng đường huyết của người bệnh nhanh chóng giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị kịp thời

Máy đo mức độ đường huyết nhờ sensor của máy đọc trên que thử sau khi que đã được phủ giọt máu của bệnh nhân. Kết quả thử đường huyết bằng que (Dextrotix) nhanh hơn so với thử đường huyết bằng phương pháp sinh hóa, trung bình 30 giây.

2. CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân cấp cứu nghi hạ hoặc tăng đường huyết

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Không yêu cầu nhịn ăn khi nghi hạ đường huyết/cấp cứu; thử và xử trí ngay theo tình trạng/y lệnh.

- Dụng cụ lấy máu mao mạch

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

- Máy thử đường huyết có 2 loại

+ Gắn que vào máy trước khi lấy mẫu máu

+ Gắn que vào máy sau khi lấy mẫu máu

- Que thử đường huyết tương ứng máy

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Kiểm tra máy phù hợp với que thử

Gắn que thử vào khe của máy sao cho màn hình xuất hiện dấu hiệu giọt máu nhấp nháy.

Xác định vị trí đâm kim:

Chọn vị trí và độ sâu theo tuổi, cân nặng và lancet; tránh giữa gót/đầu ngón hoặc vùng giảm tưới máu.

Lựa chọn mặt bên ngón khi phù hợp kích thước/tuổi và IFU; không dùng đồng thời tuổi 6 tháng và cân nặng >10 kg như quy tắc chung.

Sát trùng da, đợi khô

Đâm lancet, để phần ngoài que thử thấp hơn vị trí đâm và giọt máu phủ đầy.

Dùng gòn khô ấn chặt vị trí đâm

Đọc theo máy/IFU, ghi giá trị, đơn vị mmol/l hoặc mg/dl và giờ; kết quả bất thường/không phù hợp cần xác nhận xét nghiệm khi chỉ định nhưng không trì hoãn xử trí hạ đường huyết.

HI: vượt khoảng đo, báo bác sĩ và xác nhận theo tình trạng; không ghi thành một giá trị số giả định.

LO: có thể hạ đường huyết nặng, gọi bác sĩ/xử trí theo phác đồ và xác nhận, không chỉ thay que rồi chờ.

Lấy que thử ra khỏi máy bằng cách nhấn nút tháo bỏ que thử cho que thử rơi vào bồn hạt đậu

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/infection-control/index.html

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-13. MÁY TRUYỀN DỊCH

1. ĐẠI CƯƠNG

Truyền các loại dịch vào cơ thể người bệnh theo đúng tốc độ, thể tích và thời gian để đạt hiệu quả điều trị tối ưu.

Tốc độ truyền dịch được điều khiển bởi sensor hồng ngoại đếm giọt gắn ở bầu dịch truyền, nên tốc độ dịch truyền sẽ đều và chính xác đúng tốc độ được cài đặt.

2. CHỈ ĐỊNH

- Truyền dịch với tốc độ chính xác
- Truyền thuốc: aminophylin, kháng sinh,…
- Giữ thông catheter đặt vào động mạch, tĩnh mạch trung ương

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

+ Hướng dẫn gia đình giữ tư thế an toàn cho trẻ trong khi truyền dịch.

- Chai dịch truyền theo y lệnh

Dây truyền đúng loại tương thích bơm; hệ số giọt là giọt/ml, không ghi 15–20–60 giọt/phút như đặc tính dây.

Dung dịch và thể tích bơm rửa theo đường/cân nặng, không cố định 5 ml.

- Gòn, dung dịch cồn 70 độ
- Dung dịch sát trùng tay nhanh
- Mâm

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

- Máy truyền dịch
- Bồn hạt, trụ treo

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Rửa tay

Chuẩn bị dụng cụ

Chuẩn bị chai dịch truyền theo y lệnh

Cắm dây truyền vào chai dịch truyền và đuổi khí

+ Cố định máy và treo chai dịch truyền lên trụ treo. Cắm điện 220V

+ Mở cửa máy, đặt dây truyền dịch vào và đóng cửa lại

Lắp bộ dây/sensor nếu model yêu cầu theo IFU, không coi mọi bơm dùng cảm biến giọt.

+ Mở máy ấn nút “ POWER”

Cài tổng thể tích và giới hạn theo y lệnh/model.

Cài ml/giờ và đơn vị đúng, kiểm tra độc lập khi cần.

+ Sát trùng tay nhanh

Đánh giá đường truyền theo quy trình; không hút/bơm mạnh để kiểm tra, đặc biệt nghi thoát mạch.

Nối vô khuẩn, bảo đảm cơ chế chống chảy tự do; mở khóa theo IFU sau sẵn sàng.

+ Ấn nút “ START” cho máy hoạt động

Không PURGE khi nối trẻ. Đuổi khí khi tách người bệnh theo IFU; xử trí tắc/khí trong dây an toàn, không đẩy vào trẻ.

Kiểm tra hoạt động: quan sát nhỏ giọt ở bầu, đường truyền, nơi tiêm

Dọn dẹp dụng cụ, ghi hồ sơ: ngày, giờ bắt đầu, tên dịch truyền, số lượng, tốc độ, điều dưỡng thực hiện

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Nghi thoát mạch: ngừng truyền, không bơm rửa, giữ catheter ban đầu cho đánh giá/hút thuốc khi phù hợp; báo bác sĩ, ghi thuốc/vùng/thể tích và tưới máu. Tắc: không dùng PURGE hoặc tăng áp đẩy cục máu vào trẻ; khi tháo tắc phải tránh bolus sau giải phóng áp theo IFU. Nghi đứt catheter phải báo ngay, không chỉ đặt lại.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-14. DINH DƯỠNG QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

Đưa thức ăn qua ống thông vào dạ dày để nuôi dưỡng bệnh nhân

2. CHỈ ĐỊNH

+ Sanh non < 32 tuần hoặc sanh non > 32 tuần + bú nuốt yếu. Trẻ sanh non khi bú làm tăng tình trạng suy hô hấp hoặc cơn ngưng thở.

+ Không khả năng bú hoặc nuốt hoặc dễ bị sặc khi bú hoặc nuốt:

Bệnh lý não: sanh ngạt, xuất huyết não màng não, vàng da nhân, viêm màng não

Bệnh lý hầu họng: sứt môi, chẻ vòm hầu, tịt mũi sau, lưỡi to

Bệnh nhân có hỗ trợ hô hấp: thở máy

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Suy hô hấp nặng chưa được hỗ trợ hô hấp

Đang sốc, co giật

Xuất huyết tiêu hóa

Nghi ngờ bệnh lý ngoại khoa cần can thiệp

Giai đoạn đầu hậu phẫu đường tiêu hóa

Trong 6 giờ đầu sau thay máu

Viêm ruột hoại tử sơ sinh trong giai đoạn đầu

Dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

Không cho ăn/thuốc trước xác nhận vị trí ống; không dùng nghe bơm khí hay thử nhúng nước. RCH dùng pH dịch hút ≤5; ngưỡng/phương pháp phải được bệnh viện xác nhận. Không đủ bằng chứng thì dừng, báo bác sĩ và xác nhận hình ảnh khi cần.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Đặt người bệnh nằm đầu cao 30-45 độ trong và sau khi ăn 30 phút.

Ống thông dạ dày

- Ống tiêm nhựa 10 hay 20ml
- Dây nối bơm tiêm
- Dây truyền nhỏ giọt

Gạc

Ly nước chín

Găng sạch

Mâm sạch

Ống nghe

Băng keo

Dung dịch sát trùng tay nhanh

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Mang khẩu trang, rửa tay

Chuẩn bị dụng cụ chọn loại ống, cỡ ống phù hợp và mang đến giường bệnh nhân

Gắn lồng treo vào chai thức ăn

Gắn dây nhỏ giọt vào chai thức ăn, đuổi khí. Đối với sơ sinh, rút sữa qua ống bơm tiêm, gắn dây nối và đuổi khí trước khi gắn vào máy bơm.

Kiểm tra vị trí ống thông dạ dày:

Kiểm tra dấu chiều dài và dịch hút/pH theo quy trình được phê duyệt; dịch hút đơn thuần không đủ khi nghi sai vị trí.

Không nghe bơm khí để xác nhận; không đủ bằng chứng thì không sử dụng, báo bác sĩ và xác nhận X-quang khi chỉ định.

Cho ăn theo lượng/tốc độ cá thể và bơm/kết nối đường tiêu hóa phù hợp, không áp 30–60 phút cho mọi trẻ.

Theo dõi người bệnh trong quá trình cho ăn

Kết thúc cho ăn

+ Gỡ bỏ dây chai cho ăn

Tráng ống bằng nước và lượng cá thể theo tuổi/tổng dịch, không bơm mạnh khi tắc.

Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ

Đánh giá dung nạp sơ sinh theo kế hoạch; hút tồn dư khi có chỉ định, không bắt buộc mọi cữ.

Tồn dư: ghi lượng/màu, triệu chứng và báo theo kế hoạch; không tự bơm trả hoặc giảm sữa chỉ vì >30%.

Bác sĩ đánh giá dung nạp và quyết định dẫn lưu/chế độ, không dùng hai cữ >30% làm chỉ định tự động.

Thuốc chống trào ngược chỉ khi có chỉ định riêng; không dùng thường quy hay ấn định thời gian 20–30 phút cho mọi thuốc.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Nôn, mật/máu, bụng chướng, tím/ngừng thở: ngừng ăn, đánh giá và báo bác sĩ. Xử trí tồn dư theo toàn trạng/phác đồ, không tự bơm trả/bỏ hoặc giảm cữ chỉ từ tỷ lệ phần trăm.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và

tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Nasogastric_and_Orogastric_Tube_Insertion_and_Management/

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-15. BƠM THUỐC TĨNH MẠCH QUA KHÓA LƯU KIM

1. ĐẠI CƯƠNG

Đưa thuốc qua đường tĩnh mạch an toàn, giảm nguy cơ nhiễm trùng

2. CHỈ ĐỊNH

Thuốc tiêm tĩnh mạch trực tiếp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Thuốc dùng đường khác: bắp, ngoài da, uống

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Dụng cụ vô trùng:

- Ống tiêm 3ml, 5ml (rút thuốc)
- Ống tiêm 3ml chứa Nacl 0.9%: 2 ống
- Gạc alcohol, gòn khô

Dụng cụ khác- thuốc:

- Mâm
- Găng tay sạch
- Thuốc theo y lệnh
- Dung dịch sát trùng tay nhanh
- Hộp thuốc chống sốc phản vệ
- Bồn hạt đậu
- Hộp đựng vật sắt nhọn

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. Báo và giải thích cho bệnh nhân, thân nhân

2. Mang khẩu trang, rửa tay.

3. Chuẩn bị dụng cụ, thuốc theo y lệnh và mang đến giường bệnh nhân.

4. Thực hiện 3 kiểm tra 5 đối chiếu.

5. Tiến hành kỹ thuật:

Sát trùng tay nhanh, mang găng sạch

Sát trùng khóa lưu kim

Kiểm tra đường truyền/cổng theo IFU và kỹ thuật vô khuẩn; sát khuẩn cổng, chờ khô, dùng kết nối phù hợp. Không chọc kim vào cổng không dành cho kim, không bơm thử khi nghi thoát mạch.

Bơm đúng nồng độ/tốc độ và tương hợp theo y lệnh/cân nặng, quan sát vị trí; dừng khi đau/phồng hoặc bất thường.

Bơm rửa thể tích phù hợp đường truyền và cân nặng, tính tổng dịch; không đẩy bolus thuốc nguy cơ cao còn trong dây.

Dùng gòn khô lau khóa lưu kim.

Bỏ kim tiêm vào hộp đựng vật sắc nhọn, ống tiêm vào rác y tế.

6. Dọn dẹp dụng cụ.

7. Rửa tay, ghi hồ sơ

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Nghi thoát mạch: ngừng truyền, không bơm rửa, giữ catheter ban đầu cho đánh giá/hút thuốc khi phù hợp; báo bác sĩ, ghi thuốc/vùng/thể tích và tưới máu. Tắc: không dùng PURGE hoặc tăng áp đẩy cục máu vào trẻ; khi tháo tắc phải tránh bolus sau giải phóng áp theo IFU. Nghi đứt catheter phải báo ngay, không chỉ đặt lại.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Peripheral_Extravasation_Injuries__Initial_management_and_washout_procedure/

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-16. HÚT ĐÀM MŨI MIỆNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Hút đàm nhớt ra khỏi mũi miệng

2. CHỈ ĐỊNH

Ứ đọng đàm nhớt nhiều vùng hầu họng

Nghẹt đàm

Nôn ói bệnh nhân hôn mê

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Ống hút đàm

Chén chung vô trùng

Dung dịch Nacl 0.9% dùng tráng ống

Mâm sạch

Dung dịch sát trùng tay nhanh

Bồn hạt đậu

Găng tay sạch

3.3 Dụng cụ khác

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

- Máy đo độ bảo hòa oxy, ống nghe

- Máy hút đàm hoặc hệ thống hút trung tâm

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. Báo và giải thích thân nhân, bệnh nhân

2. Đặt trẻ nằm ngửa, tư thế nghiêng bên nếu trẻ nôn ói

3. Đo và theo dõi SpO2, trước và trong khi hút

4. Mang khẩu trang, rửa tay.

5. Chuẩn bị dụng cụ, mang đến giường người bệnh.

6. Ống hút đàm cỡ thích hợp, mở bao ống hút (còn giữ ống hút trong bao)

7. Rót Nacl 0.9% vào chén chun

8. Điều chỉnh áp lực của máy hút đàm:

+ Sơ sinh, trẻ nhỏ: - 45 mmHg → - 65 mmHg

+ Trẻ lớn: - 85 mmHg → - 110 mmHg

9. Gắn ống hút đàm vào dây nối máy hút (vẫn giữ ống hút trong bao)

10. Sát trùng tay nhanh

11. Mang găng tay sạch

12. Hút đàm:

Hút đàm qua miệng:

+ Cầm ống hút bằng tay (P)

+ Đưa ống hút vào miệng bệnh nhân đến vùng hầu họng. Khi đưa ống vào không được hút để tránh làm thiếu oxy cho bệnh nhân.

+ Hút đàm: dùng ngón cái bịt kín lỗ ống hút. Hút ngắt quãng

+ Nếu đàm đặc cần tráng ống hút bằng Nacl 0.9 %

+ Tiếp tục hút đàm nếu cần

Vỗ rung chỉ khi có chỉ định riêng, không áp thường quy mọi bệnh hô hấp.

Hút đàm qua mũi:

Không đưa lại ống đã hút miệng vào mũi; dùng ống/vật tư phù hợp tránh mang vi khuẩn giữa vị trí.

+ Cầm ống hút bằng tay (P), ước lượng chiều dài đoạn ống hút đưa vào mũi bằng khoảng cách từ chóp mũi → trái tay.

+ Đưa ống hút vào mũi bệnh nhân đến vùng hầu họng bằng chiều dài đã ước lượng. Khi đưa ống vào không được hút.

+ Hút đàm: dùng ngón cái bịt kín lỗ ống hút. Hút đàm

+ Nếu đàm đặc cần tráng ống hút bằng dung dịch Nacl 0.9%.

Trẻ cần hỗ trợ oxy/CPAP: phối hợp duy trì oxy hóa, thời gian gián đoạn tối thiểu và theo dõi liên tục; khi ngừng thở/nhịp chậm/SpO_2 giảm phải dừng hút, hỗ trợ và gọi bác sĩ.

Tiếp tục hút đàm nếu cần.

13. Nghe phổi và đánh giá tình trạng hô hấp Sp02 sau hút đàm

14. Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Hút khi có chỉ định, cỡ/áp lực/độ sâu/thời gian theo tuổi và hướng dẫn được duyệt; không hút sâu/lặp liên tục. Dừng khi SpO_2 giảm, nhịp chậm, ngưng thở hoặc chảy máu, hỗ trợ hô hấp và báo bác sĩ. Không bơm nước muối vào đường thở thường quy; ống sau dùng ở miệng không đưa vào mũi.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và

tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-17. THIẾT LẬP ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

Thiết lập đường truyền tĩnh mạch ngoại biên để tiêm thuốc, truyền dịch, truyền máu

2. CHỈ ĐỊNH

Truyền dịch

Truyền máu và các sản phẩm của máu

Tiêm thuốc đường tĩnh mạch

Dinh dưỡng đường tĩnh mạch

VỊ TRÍ TIÊM

- Tĩnh mạch chi: lưng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, cổ chân. Trong đó tĩnh mạch lưng bàn tay thường được chọn do dễ tiêm, dễ cố định.

- Tĩnh mạch vùng đầu: hai bên thái dương. Hạn chế chích tĩnh mạch đầu vì nếu thoát mạch sẽ hoại tử lâu lành, mất thẩm mỹ.

- Sốc: chọn tĩnh mạch chi để đảm bảo tốc độ dịch truyền

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Kim luồn:

+ Trẻ < 1 tuổi kim luồn 24G

+ Trẻ 1 – 15 tuổi kim luồn 22G

Ống tiêm 3ml

Băng keo cá nhân, Tegaderm

Gòn viên

Mâm sạch

Bồn hạt đậu

Găng tay sạch

- Dây thắt mạch
- Nẹp cố định
- Băng keo cuộn

Thuốc, dung dịch sát trùng:

- Dung dịch Nacl 0.9 %
- Dung dịch sát trùng tay nhanh
- Alcohol pass

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. Báo và giải thích thân nhân, bệnh nhân

2. Đặt bệnh nhân tư thế thích hợp. Chọn và bộc lộ vị trí tĩnh mạch

3. Mang khẩu trang, rửa tay.

4. Chuẩn bị dụng cụ, mang đến giường người bệnh. Ống tiêm 3ml rút sẵn Nacl 0.9 %

5. Sát trùng tay nhanh, mang găng tay sạch

6. Cột garo

7. Sát trùng da vùng tiêm ít nhất 3 lần

+ Sát trùng dọc theo tĩnh mạch từ dưới lên, rộng ra xung quanh hoặc kiểu xoắn ốc

+ Để khô cồn giữa 2 lần sát trùng và trước khi tiêm

8. Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch

+ Tiêm tĩnh mạch

* Tay phải cầm kim luồn để mặt vát hướng lên trên

* Đâm kim qua da vào tĩnh mạch một góc 30 độ cùng lúc dùng ngón cái bàn tay trái căng da phía dưới chỗ chích đồng thời giữ cố định chi. Trường hợp trẻ quấy khóc giãy giụa có thể nhờ người phụ giữ trẻ

* Khi tiêm vào tĩnh mạch sẽ thấy máu chảy ra ở chuôi kim, tay phải giữ cố định kim không luồn thêm. Tay trái tháo dây garo

+ Luồn kim luồn: Lùi nòng kim một ít khoảng 0.5 – 1 cm cùng lúc luồn kim luồn nhẹ nhàng vào trong lòng mạch, sau đó rút bỏ nòng kim.

+ Kiểm tra kim luồn nằm trong tĩnh mạch:

* Dùng ống tiêm chứa sẵn Nacl 0.9% rút thấy máu vừa xuất hiện ở ống tiêm thì bơm Nacl 0.9% vào

* Nếu kim vào đúng tĩnh mạch sẽ cảm giác nhẹ tay và không phù nơi tiêm

* Gắn khóa lưu kim trong trường hợp dùng để bơm thuốc hoặc gắn dịch truyền nếu có chỉ định

+ Cố định:

* Dán cố định kim luồn bằng băng keo cá nhân hoặc băng keo trong (Tegaderm). Ghi ngày, giờ, tên điều dưỡng thực hiện lên trên băng keo và dán lên vùng tiêm

* Nẹp cố định với băng cuộn để giữ kim được lâu nếu vị trí tiêm tĩnh mạch gần khớp hoặc khi cần chuyển viện.

9. Dặn dò bệnh nhân hoặc thân nhân chăm sóc vùng lưu kim luồn

10. Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Nghi thoát mạch: ngừng truyền, không bơm rửa, giữ catheter ban đầu cho đánh giá/hút thuốc khi phù hợp; báo bác sĩ, ghi thuốc/vùng/thể tích và tưới máu. Tắc: không dùng PURGE hoặc tăng áp đẩy cục máu vào trẻ; khi tháo tắc phải tránh bolus sau giải phóng áp theo IFU. Nghi đứt catheter phải báo ngay, không chỉ đặt lại.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/intravenous_access_peripheral/

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-18. THỞ OXY QUA CANNULA 2 MŨI

1. ĐẠI CƯƠNG

Cung cấp oxy qua mũi để điều trị tình trạng thiếu oxy máu

2. CHỈ ĐỊNH

Tím trung ương

Rút lõm ngực nặng

Thở nhanh

Thở rên ở trẻ nhỏ < 2 tháng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

Nguồn oxy: bình hoặc tường

Bình làm ẩm

Nước cất vô trùng để đổ bình làm ẩm

Cannula hai mũi: cỡ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ lớn

Que gòn

Ưu điểm của cannula hai mũi so với catheter một mũi là không gây sang chấn, tổn thương niêm mạc mũi, chảy máu mũi, và trẻ dễ chấp nhận. Nồng độ FiO2 đạt được tương đương với catheter một mũi.

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

Lưu lượng kế

Máy đo SpO2

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. Báo và giải thích thân nhân, bệnh nhân

2. Mang khẩu trang, rửa tay.

3. Chuẩn bị dụng cụ:

- Chọn cỡ cannula phù hợp theo tuổi: sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ lớn

- Đổ nước cất vào bình làm ẩm

4. Mang đến giường, và đặt trẻ nằm đầu cao

5. Đánh giá tình trạng hô hấp bệnh nhân và đo SpO2

6. Kỹ thuật:

- Vệ sinh mũi sạch sẽ bằng que gòn

- Gắn dây nối oxy với bình làm ẩm

Lưu lượng theo tuổi, loại cannula và IFU/y lệnh; không lấy tối đa 6 lít/phút cho mọi trẻ.

- Kiểm tra oxy ra bằng cách thử trên lưng bàn tay hoặc trên gò má

- Gắn cannula vào mũi: cho hai nhánh nhỏ vào mũi. Sau đó cố định cannula bằng cách:

+ Quàng qua tai và xuống cằm: trẻ lớn

+ Choàng ra sau gáy: trẻ nhỏ

Mục tiêu SpO_2 theo tuổi thai/bệnh và chỉ định, đặc biệt sơ sinh; không áp 92–96% cho mọi đối tượng. Theo dõi và báo khi không đạt dù hỗ trợ, không tăng ngoài giới hạn thiết bị.

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Theo dõi liên tục oxy hóa và tình trạng hô hấp khi cần; mục tiêu SpO_2 theo tuổi thai/bệnh, không áp một mục tiêu cho tất cả. Xấu đi, ngưng thở/nhịp chậm hoặc nghi tràn khí: hỗ trợ ngay, gọi bác sĩ; không trì hoãn nâng mức hỗ trợ bằng sửa máy kéo dài. Kiểm tra da mũi, áp lực, FiO_2, làm ẩm và rò hệ theo IFU.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Oxygen_delivery/

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

N-2025-19. TRUYỀN DỊCH

1. ĐẠI CƯƠNG

Hồi phục lại khối lượng tuần hoàn trong các trường hợp sốc giảm thể tích. Đưa thuốc vào cơ thể. Nuôi dưỡng khi bệnh nhân không ăn uống được bằng đường tiêu hóa, suy dinh dưỡng nặng. Giải độc

2. CHỈ ĐỊNH

- Hồi sức sốc giảm thể tích: sốt xuất huyết, nhiễm trùng huyết,….
- Bù dịch: tiêu chảy mất nước, bỏng
- Nuôi dưỡng: trước và sau mổ, dinh dưỡng đường tĩnh mạch
- Tăng thải độc chất qua thận: ngộ độc cấp
- Đưa thuốc vào cơ thể qua đường tĩnh mạch: kháng sinh, thuốc vận mạch,…
- Suy tim, phù phổi cấp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ/người phụ trách xác nhận theo mục đích, tình trạng trẻ và hướng dẫn chuyên môn/IFU; không sử dụng khi thiếu điều kiện an toàn hoặc không đúng chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Hai định danh, tuổi, tuổi thai khi sơ sinh, cân nặng kg hiện tại, dị ứng và thuốc đã dùng; kiểm tra liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tổng dịch và đơn vị cài máy. Trẻ nhỏ cần hỗ trợ an toàn, không cưỡng ép giữ để làm khi nguy cơ. Kiểm tra độc lập thuốc/chế phẩm và thông số nguy cơ cao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng/người hành nghề đã đào tạo; bác sĩ chỉ định và hỗ trợ, kỹ thuật xét nghiệm/thiết bị theo phân công.

5.2. Thuốc

Thuốc/dịch/chế phẩm theo y lệnh và nhãn; cân nặng, mg/kg, trần, nồng độ và ml/tốc độ được xác nhận. Không có thuốc bắt buộc nếu mục kỹ thuật không cần.

5.3. Vật tư

3.1 Dụng cụ vô trùng

- Dây truyền dịch (1ml = 60 giọt, 1 ml = 20 giọt, 1ml = 15 giọt)
- Ống tiêm 3ml chứa Nacl 0.9%
- Gòn, dung dịch sát trùng

3.2 Dụng cụ sạch

- Mâm sạch
- Găng tay sạch
- Dụng dịch sát trùng tay nhanh

- Bồn hạt đậu

3.3 Dụng cụ khác

- Đồng hồ có kim giây để đếm giọt

- Thùng đựng vật sắt nhọn

- Phiếu theo dõi dịch truyền

- Hộp chống sốc phản vệ

3.4 Dịch truyền

- Theo y lệnh

Đúng cỡ và loại theo tuổi, xét nghiệm, IFU; vật tư xuyên da dùng một lần, phương tiện phòng hộ và hộp sắc nhọn. Danh mục nguồn không thay y lệnh.

5.4. Trang thiết bị

- Trụ treo

Đúng model, nguồn điện, phụ kiện, hiệu chuẩn/bảo trì và IFU; thử báo động và phương tiện cấp cứu trước dùng. Không vận hành theo thông số chưa được xác nhận.

5.5. Người bệnh

Giải thích theo tuổi và người chăm sóc; nhận định tình trạng ban đầu, dị ứng, đồng ý theo quy định và kế hoạch hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, cân nặng/tuổi, kết quả cần thiết, kế hoạch thuốc/dịch/theo dõi và giấy đồng ý khi yêu cầu.

5.7. Thời gian thực hiện

Thời gian theo kỹ thuật, đáp ứng và thiết bị; ghi thực tế, không để thời gian dự kiến trì hoãn cấp cứu.

5.8. Địa điểm thực hiện

Nơi đủ điều kiện và hỗ trợ cấp cứu theo kỹ thuật; phòng xét nghiệm hoặc khu hồi sức khi cần.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu đúng trẻ, kỹ thuật, vị trí, y lệnh, thuốc/liều/thông số/IFU, vật tư và năng lực; dừng khi thiếu/sai.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. Báo và giải thích thân nhân, bệnh nhân

2. Cho bệnh nhân nằm tư thế thích hợp

3. Lấy dấu hiệu sinnh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở

4. Mang khẩu trang, rửa tay.

5. Chuẩn bị dụng cụ:

- Kiểm tra chai dịch truyền: tên, hạn dùng, nguyên vẹn, không đổi màu, không cặn lắng

- Ghi tên bệnh nhân, ngày, giờ, tốc độ truyền lên chai dịch

- Chọn loại dây dịch truyền theo y lệnh

6. Mang đến giường bệnh nhân, thực hiện 3 kiểm tra 5 đối chiếu

7. Mở nắp chai, sát trùng, cắm dây dịch truyền, khóa dây dịch truyền

8. Treo chai dịch lên trụ, đuổi khí

9. Sát trùng tay nhanh, mang găng

10. Kiểm tra kim luồn nằm trong lòng mạch và gắn dây dịch truyền:

- Ngay sau khi tiêm tĩnh mạch: dùng ống tiêm 3ml có chứa Nacl 0.9% rút ra nếu thấy có máu ở ống tiêm (kim nằm trong lòng mạch), gắn dây truyền dịch vào kim luồn.

- Đang lưu kim: sát trùng khóa lưu kim, dùng ngón tay ấn trên đường đi tĩnh mạch, mở khóa lưu kim, gắn ống tiêm chứa Nacl 0.9% rút ra nếu thấy có máu ở ống tiêm (kim nằm trong lòng mạch), gắn dây truyền dịch vào kim luồn.

11. Chỉnh tốc độ theo y lệnh

12. Quan sát nơi tiêm: nếu phù ngưng dịch, thiết lập lại đường tĩnh mạch khác

13. Hướng dẫn thân nhân: báo ngay khi có cảm giác đau, phù nơi tiêm, cảm giác ớn lạnh, nổi gai ốc, tức ngực, khó thở hay sốt, không tự điều chỉnh tốc độ.

14. Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ

Kết thúc: đánh giá trẻ, ghi thời gian, thuốc/thể tích/tốc độ hoặc thông số thực dùng và đáp ứng, thu dọn đúng kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao người nhận và kế hoạch theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi trước, trong và sau theo tình trạng: tri giác, hô hấp, SpO_2, mạch/huyết áp, nhiệt độ, đau và vùng can thiệp; ghi tần suất cụ thể theo nguy cơ và y lệnh. Báo động máy không thay đánh giá trẻ; không chỉ tắt âm thanh khi chưa giải quyết nguyên nhân.

Nghi thoát mạch: ngừng truyền, không bơm rửa, giữ catheter ban đầu cho đánh giá/hút thuốc khi phù hợp; báo bác sĩ, ghi thuốc/vùng/thể tích và tưới máu. Tắc: không dùng PURGE hoặc tăng áp đẩy cục máu vào trẻ; khi tháo tắc phải tránh bolus sau giải phóng áp theo IFU. Nghi đứt catheter phải báo ngay, không chỉ đặt lại.

Các tai biến khác: dừng can thiệp liên quan, gọi hỗ trợ và xử trí theo phác đồ Nhi. Phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT, không trì hoãn adrenaline tiêm bắp khi đã có chỉ định theo mức độ. Ghi/báo cáo sự cố, đánh giá lại trước tiếp tục.

Tài liệu tham khảo và điều kiện xác nhận

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương; TT31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng; TT51/2017/TT-BYT về phản vệ. Nguồn QTKT KHOA NHI 2025 và

tài liệu Nhi Đồng 1 năm 2007 được nguồn dẫn: không mặc định thông số năm 2007 phù hợp thiết bị hiện tại.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Peripheral_Extravasation_Injuries__Initial_management_and_washout_procedure/

Bác sĩ/chuyên khoa và người quản lý thiết bị xác nhận IFU, phác đồ và thông số trước ban hành; liều/tốc độ không ghi sẵn theo một tuổi để dùng cho mọi trẻ.

Bảng kiểm an toàn áp dụng cho từng mục

Nội dung	Đạt / Chưa đạt / Không áp dụng
Hai định danh, tuổi/tuổi thai và cân nặng	……
Chỉ định, phạm vi kỹ thuật, người đủ năng lực	……
Thuốc/chế phẩm, liều và đơn vị được kiểm tra	……
Model/IFU, phụ kiện và thông số xác nhận	……
Chuẩn bị vô khuẩn/phòng hộ phù hợp	……
Kế hoạch và phương tiện cấp cứu	……
Theo dõi, đáp ứng, ghi thời gian/thông số	……
Bàn giao và hướng dẫn cho người chăm sóc	……

Phiếu xác nhận chuyên môn và thiết bị

Mã/tên quy trình, danh mục được phép: ……

Trẻ: định danh, tuổi/tuổi thai, cân nặng và ngày cân: ……

Thuốc/liều mg/kg, trần mg, nồng độ, ml, tốc độ, tổng dịch: ……

Truyền máu: chế phẩm, tương hợp, định danh túi, ml và ml/giờ: ……

Chiếu đèn: bilirubin/tuổi giờ/ngưỡng, model, cường độ, khoảng cách, lịch kiểm tra: ……

CPAP/oxy: model, áp lực, FiO_2, lưu lượng, nhiệt/làm ẩm, mục tiêu SpO_2, báo động: ……

Nuôi ăn/rửa dạ dày: vị trí ống xác nhận, lượng/tốc độ cá thể và tiêu chí dừng: ……

Bơm/ly tâm/máy đường huyết: IFU/phiên bản, chương trình, đơn vị, kiểm chuẩn và xử lý sự cố: ……

Người thẩm định/phê duyệt; số quyết định/ngày hiệu lực: ……

Đối chiếu thêm quy trình truyền máu Việt Nam và hướng dẫn sơ sinh/chống độc, IFU thực tế trước triển khai. Bản nguồn giữ nguyên; 55 bảng nguồn, gồm bảng kiểm lặp và thông số cũ, được thay bằng chuẩn bị 5.1–5.9, theo dõi mục 7 và biểu mẫu xác nhận; không tiếp tục dùng bảng cũ mà chưa thẩm định.